



Análise Exploratória de Dados

Exercício:

Imagine que você tem interesse em investigar o perfil de pessoas entre 18 e 25 anos, residentes em João Pessoa, e que possuem um determinado tipo de doença. Suponha que estas pessoas são atendidas em 10 postos de saúde da cidade:

JOÃO PESSOA	CAPS III (Caminhar* e Gutemberg Botelho*)/ CAPS AD III (David Capistrano* e Jovem Cidadão)/ CAPSi/ UAI/ SRTs*
-------------	---

CAPS III (Caminhar* e Gutemberg Botelho*)/ CAPS AD III (David Capistrano* e Jovem Cidadão)/ CAPSi/ UAI/ SRTs*

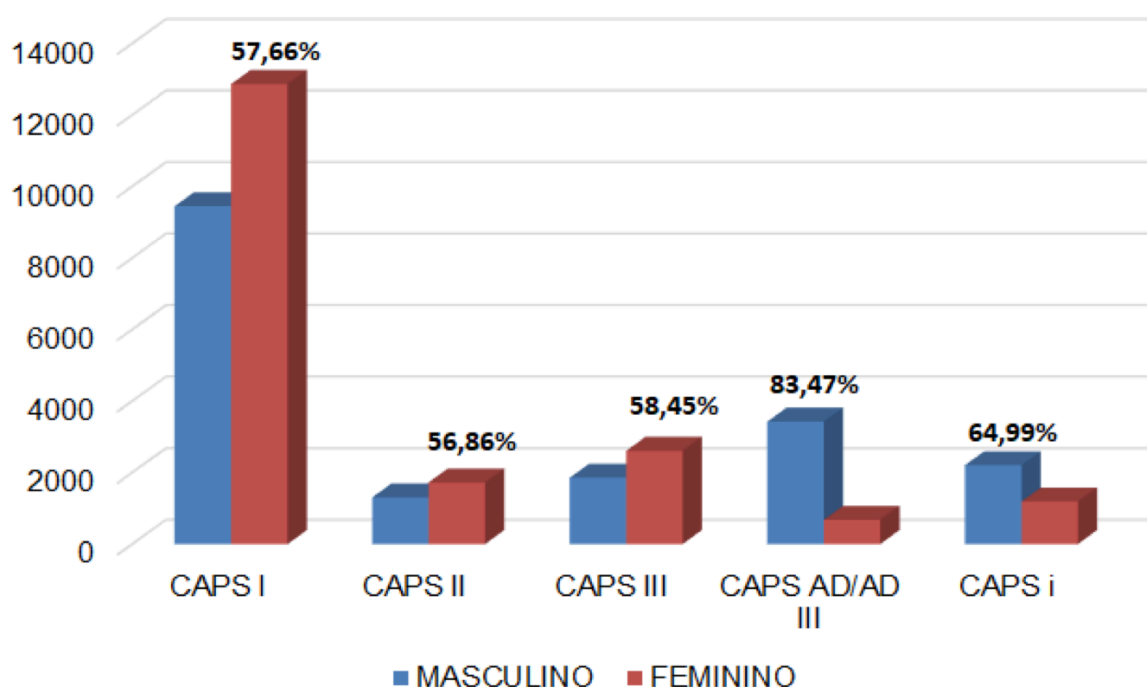
Sexo.

As distribuições da população atendida nos Centros de Atenção Psicossocial, segundo sexo² são apresentadas no Gráfico 3, onde se pode observar que nos serviços CAPS I, CAPS II e CAPS III possuem mais pessoas do sexo feminino em comparação

com os CAPS AD, CAPS AD III e CAPSi que atendem uma maior quantidade de pessoas do sexo masculino.

Esse perfil encontrado nos CAPS I, II e III é semelhante, no qual um pouco mais da metade das pessoas são do sexo feminino. Já nos CAPS AD/AD III, do total de 4102 pessoas atendidas, 83,47% (3424) são do sexo masculino e nos CAPSi (3391) a proporção de homens corresponde a 64,99% (2204).

GRÁFICO 3 - DISTRIBUIÇÃO DOS USUÁRIOS CAPS POR SEXO



Neste relatório foi considerado sexo biológico (designado no nascimento) como referente às características biológicas, como genitália, cromossomo, entre outros. Entende-se que há uma distinção entre a dimensão biológica e a dimensão social, na qual há pessoas em que seu gênero se identifica com o sexo biológico (cisgênero), e que há pessoas em que seu gênero difere do designado no nascimento (transgênero). Ainda há

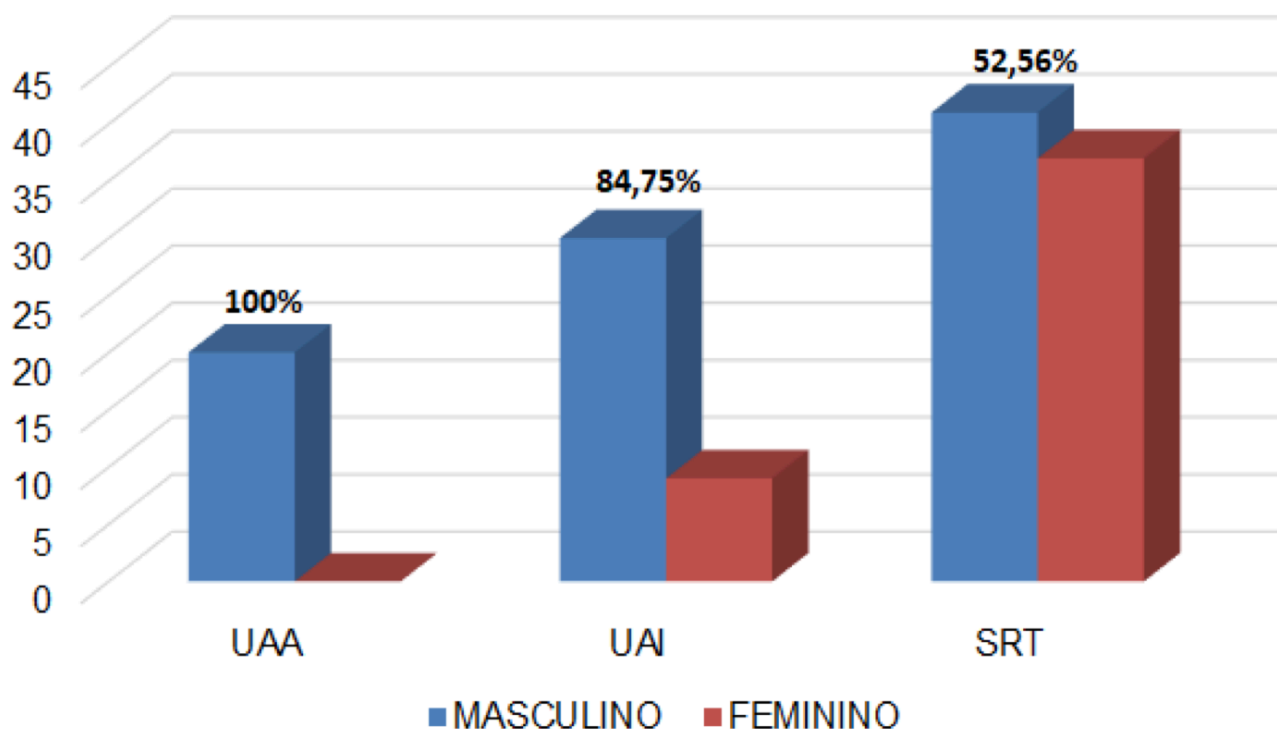
pessoas que não estão dentro da noção binária homem/mulher (OPAS; OMS, 2018).

O perfil de utilização de substâncias psicoativas pela população brasileira é apresentado no III Levantamento Nacional sobre a utilização de Drogas na População Brasileira, onde os homens, em comparação com as mulheres, relataram mais o uso de substâncias e apresentaram uma maior prevalência no acesso ao tratamento para uso de tabaco, álcool ou outras substâncias na vida (Brasil, 2019). O que corrobora com o perfil encontrado nos serviços AD da RAPS/PB.

As mulheres são um grupo mais difícil de ser acessado, em virtude do caráter privado de muitas de suas práticas, que permanecem anônimas, não conseguindo ter acesso aos serviços de tratamento especializado, devido ao preconceito e à estigmatização que lhes são impostos em diversos contextos (ELBREDER et al., 2008; BASTOS e BERTONI, 2014). Ainda nessa perspectiva, Souza (2018) afirma que “(...) a perspectiva de transgressão normativa de gênero se expressa de forma efetiva, o que coloca o comportamento de uso de drogas como não esperado dentro dos padrões normativos e hegemônicos da sociedade para as mulheres”.

Ao analisar a distribuição por sexo dos usuários nas Unidades de Acolhimento (UAs) observa-se um perfil semelhante ao dos CAPS AD/AD III, sendo uma maioria considerável do sexo masculino (Gráfico 4). Na UA Adulto que respondeu ao Monitoramento 2018.2, todos os acolhidos são do sexo masculino (20), e nas Unidades de Acolhimento Infantil 84,75% (30) dos acolhidos são jovens do sexo masculino, tendo apenas 15,25% (9) de jovens do sexo feminino acolhidas.

GRÁFICO 4 - DISTRIBUIÇÃO DOS USUÁRIOS DE UAs E SRTs POR SEXO



Legenda:

UAs Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) é constituída por um conjunto integrado e articulado de diferentes pontos de atenção para atender pessoas em sofrimento psíquico e com necessidades decorrentes uso prejudicial de álcool e outras drogas. Casa, Oficinas, Apoio a emprego, atendimentos com especialistas.

As **SRTs** no **Centro de Atenção Psicossocial (CAPS)** referem-se aos **Serviços Residenciais Terapêuticos**. Esses serviços oferecem atendimento contínuo, funcionando 24 horas por dia, inclusive em feriados e finais de semana. Eles fornecem retaguarda clínica e acolhimento noturno a outros serviços de saúde mental

Cor/Raça/Etnia

Os Gráficos 5 e 6 mostram a distribuição das usuárias e usuários da RAPS/PB de acordo com sua cor de pele, raça ou etnia e trazem como resultado que todos os serviços possuem mais pessoas com identificação de cor parda, em média 54,28%, seguido de pessoas de cor branca com 27,77% e 14,84% pessoas de cor preta. Ao analisar esse panorama, percebe-se

que o perfil majoritário é de pessoas pretas e pardas(69,12%) sendo atendidas nos serviços da RAPS/PB.

Autoras como Sueli Carneiro (2005), Abdias do Nascimento (2017) e Lélia Gonzales (2011) citados por Souza (2018) “denunciam que esse lugar de não humanidade destinado às negras e aos negros no Brasil teve como base a cor/raça como critério central. Ambos afirmam que essa política visava e visa até hoje a higienização das raças, a partir de uma prática de genocídio da população negra e da busca incessante de embranquecimento da sociedade”, fato que pode explicar um grande número de pessoas que se identificam como pessoas pardas.

Segundo o Censo Demográfico de 2010 (IBGE) na Paraíba 52,7% da população se autodeclara como parda e 5,57% como preta, assim o perfil encontrado entre as pessoas atendidas pela RAPS/PB é semelhante ao perfil de identificação de cor parda da população geral do estado, enquanto que a porcentagem de pessoas identificadas como pretas nos serviços da RAPS/PB é mais representativa quando comparada ao último Censo do IBGE na Paraíba.

média 54,28%, seguido de pessoas de cor branca com 27,77% e 14,84% pessoas de cor preta. Ao analisar esse panorama, percebe-se que o perfil majoritário é de pessoas pretas e pardas(69,12%) sendo atendidas nos serviços da RAPS/PB.

Autoras como Sueli Carneiro (2005), Abdias do Nascimento (2017) e Lélia Gonzales (2011) citados por Souza (2018) “denunciam que esse lugar de não humanidade destinado às negras e aos negros no Brasil teve como base a cor/raça como critério central. Ambos afirmam que essa política visava e visa

até hoje a higienização das raças, a partir de uma prática de genocídio da população negra e da busca incessante de embranquecimento da sociedade”, fato que pode explicar um grande número de pessoas que se identificam como pessoas pardas.

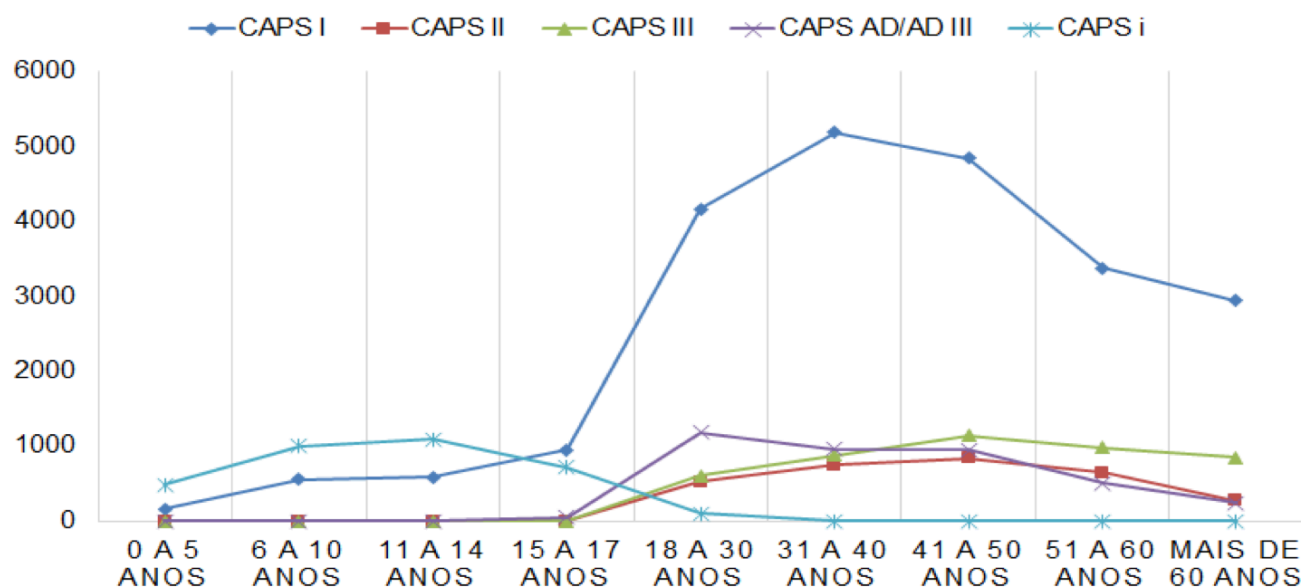
Segundo o Censo Demográfico de 2010 (IBGE) na Paraíba 52,7% da população se auto declara como parda e 5,57% como preta, assim o perfil encontrado entre as pessoas atendidas pela RAPS/PB é semelhante ao perfil de identificação de cor parda da população geral do estado, enquanto que a porcentagem de pessoas identificadas como pretas nos serviços da RAPS/PB é mais representativa quando comparada ao último Censo do IBGE na Paraíba.

Faixa Etária

Outro parâmetro utilizado para percepção da população atendida na RAPS/PB foi a idade. O gráfico abaixo mostra que a predominância da faixa etária nos CAPS I foi de 31 a 40 anos (22,79%). Nos CAPS II e CAPS III se tem mais usuárias e usuários de 41 a 50 anos (27,85% e 25,62%, respectivamente), enquanto que nos CAPS AD/AD III têm uma maior quantidade de pessoas de 18 a 30 anos

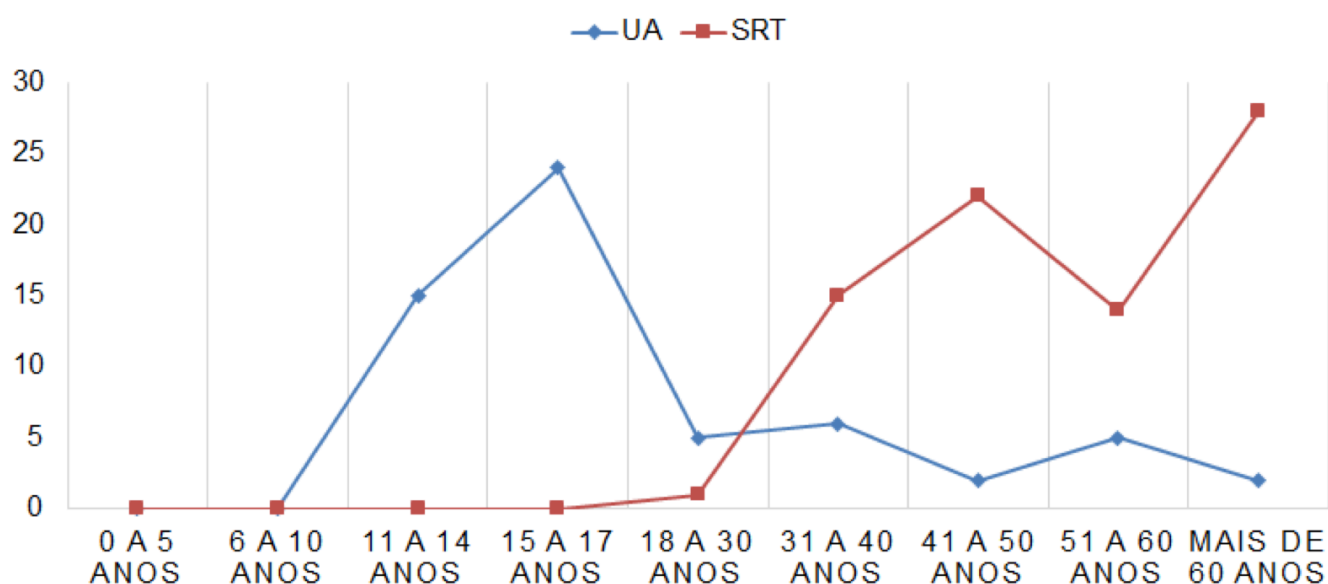
(30,48%). Como esperado, as usuárias e usuários dos CAPSi são os mais jovens e a faixa etária de 11 a 14 anos é a que mais predomina nestes serviços (32,06%).

GRÁFICO 9 - USUÁRIOS CAPS POR FAIXA ETÁRIA



Os dados dos SRTs apresentaram um perfil (Gráfico 10) com moradoras e moradores de faixa etária mais avançada, onde 35% tem mais de 60 anos. E referente aos acolhidos de UAs, como duas UAs responderam ao monitoramento, tem mais acolhidas e acolhidos com idade de 15 a 17 anos.

GRÁFICO 10 - USUÁRIOS DAS UAS E SRTS POR FAIXA ETÁRIA



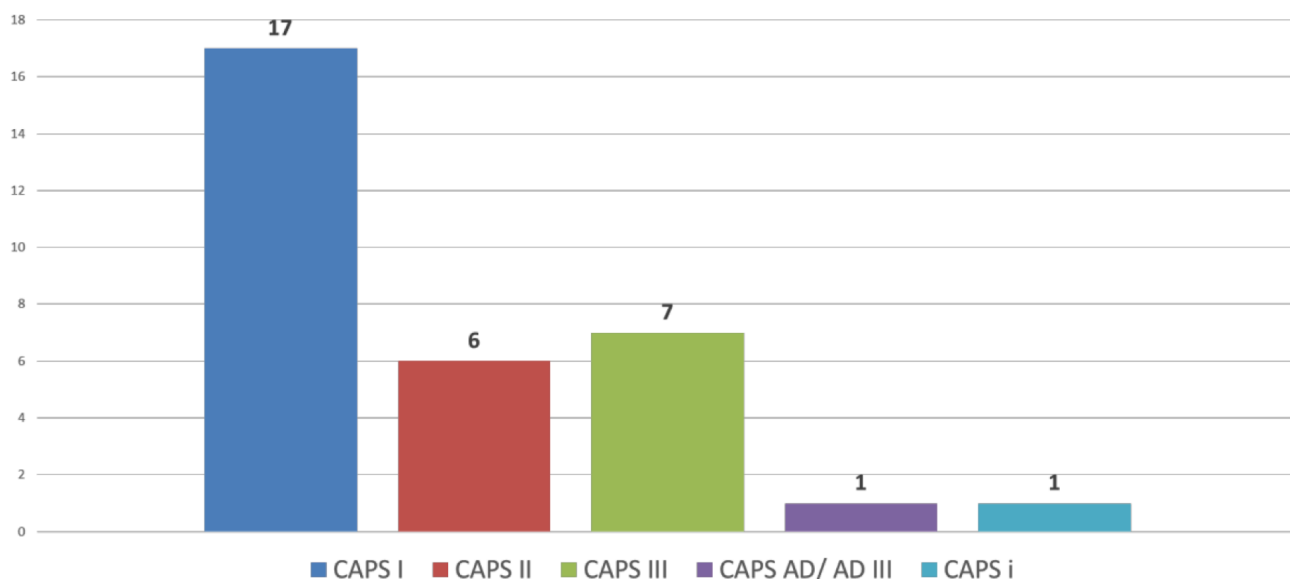
Legenda:

UAs Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) é constituída por um conjunto integrado e articulado de diferentes pontos de atenção para atender pessoas em sofrimento psíquico e com necessidades decorrentes uso prejudicial de álcool e outras drogas. Casa, Oficinas, Apoio a emprego, atendimentos com especialistas.

As **SRTs** no **Centro de Atenção Psicossocial (CAPS)** referem-se aos **Serviços Residenciais Terapêuticos**. Esses serviços oferecem atendimento contínuo, funcionando 24 horas por dia, inclusive em feriados e finais de semana. Eles fornecem retaguarda clínica e acolhimento noturno a outros serviços de saúde mental.

tentativa de suicídio é o CAPS I com 17 óbitos; seguido do CAPS III com 07 óbitos; CAPS II com 06 óbitos; CAPS AD/AD III e CAPS i com 01 óbito em cada serviço. Segundo o DATASUS, no ano de 2017 no Estado da Paraíba foram registradas 250 mortes causadas por lesões autoprovocadas voluntariamente (Fonte:<http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sim/cnv/ext10pb.def>).

GRÁFICO 21 - USUÁRIOS QUE TENTARAM SUICÍDIO COM ÓBITO



Segundo o Ministério da Saúde (2017), a existência de um CAPS no território reduz em 14% o risco de suicídio, sendo um fator

de proteção. Para além da expansão dos serviços CAPS, como fator de proteção e estratégia de prevenção ao suicídio, o Ministério da Saúde publicou no ano de 2017 a Agenda de Ações Estratégicas para a Vigilância e Prevenção do Suicídio e Promoção da Saúde no Brasil, com o objetivo de ampliar e fortalecer ações para a redução de mortes por suicídio.

Fonte da pesquisa:

<https://paraiba.pb.gov.br/diretas/saude/arquivos-1/relatorio-do-monitoramento-da-rede-de-atencao-psicossocial-na-paraiba-2018-2.pdf>

Fonte: III Levantamento Nacional Sobre o Uso de Drogas Pela População Brasileira 2017. Divulgado por: The InterceptBrasil (2019).

Indique quem é a população;

Jovens de 18 a 30 anos, usuários dependentes químicos,

Quais os possíveis parâmetros de interesse que podem ser considerados para investigação?

Idade influenciando na dependência, comparações com outras cidades, cor/ raça, sexo, estrutura de apoio.

Como você faria para obter uma amostra de pessoas nessa faixa etária?

Para uma pesquisa mais detalhada, minerada gostaria de ter acesso aos dados de idades da pesquisa realizada para cidade de João Pessoa, ainda não divulgada do último censo realizado pelo IBGE, com eles poderia mensurar em números do qual a pesquisa retrata em porcentagem; porém acredito que a base de dados realizado pelo Governo do Estado seja correta, de confiança.

Existe um cadastro que contém todos os elementos dessa população? Justifique a sua resposta.

IBGE, Banco de Dados da saúde Municipal de João Pessoa, Governo do Estado da Paraíba.